



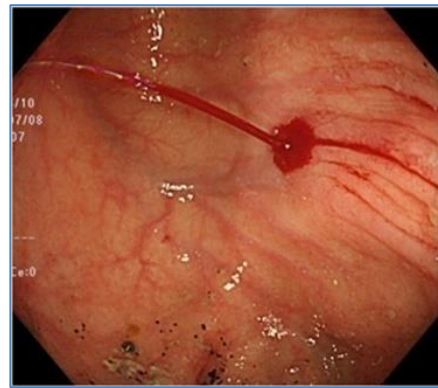
République Algérienne Démocratique Et Populaire
Ministère de L'Enseignement Supérieur et de La Recherche Scientifique
Université Salah Boubnider-Constantine III
Faculté de Médecine
Département de Médecine



COURS DES ETUDIANTS DE 4EME ANNEE DE MEDECINE
MODULE DE GASTRO ENTEROLOGIE HEPATOLOGIE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2025-2026
1ERE ROTATION

POLYCOPIE

CAT DEVANT
UNE HÉMORRAGIE DIGESTIVE BASSE



Dr. DJOUDI

Maitre-Assistant Hospitalo-Universitaire

Service de Chirurgie générale

EH Didouche Mourad

PLAN DU COURS

1 Définitions

- 1.1 Le méléna
- 1.2 L'hématochésie
- 1.3 Rectorragie
- 1.4 Saignement d'origine anale
- 1.5 Hémorragie occulte

2 Epidémiologie

3 Conduite à tenir initiale

- 3.1 Affirmer le diagnostic d'hémorragie digestive
- 3.2 Eliminer les diagnostics différentiels
- 3.3 Apprécier la gravité de l'hémorragie (retentissement)
 - 3.3.1 Démarche
 - 3.3.1.1 Interrogatoire
 - 3.3.1.2 Examen clinique
 - 3.3.1.3 Examens para-cliniques
 - 3.3.1.3.1 Les examens biologiques
 - 3.3.1.3.2 ECG
 - 3.3.1.3.3 Examen endoscopique
 - 3.3.1.4 Evaluer l'évolution
 - 3.3.2 Critères de gravité
 - 3.3.2.1 Critères de KAMMOK
 - 3.3.2.2 Autres critères :
- 3.4 Mesures thérapeutiques d'urgence

4 Diagnostic Etiologique

- 4.1 Enquete Etiologique
 - 4.1.1 Anamnèse
 - 4.1.1.1 Terrain
 - 4.1.1.2 ATCD personnels
 - 4.1.1.3 Antécédents familiaux
 - 4.1.1.4 Nature du saignement
 - 4.1.1.5 Caractères du saignement
 - 4.1.1.6 Circonstances de survenue:
 - 4.1.1.7 Rapport des rectorragies avec la défécation
 - 4.1.1.8 Prise médicamenteuse:
 - 4.1.1.9 Signes accompagnateurs
 - 4.1.1.9.1 Signes généraux
 - 4.1.1.9.2 Signes digestifs
 - 4.1.2 Examen physique
 - 4.1.2.1 Examen proctologique
 - 4.1.2.2 Examen de l'abdomen
 - 4.1.2.3 Examen général
 - 4.1.3 Examens complémentaires

4.1.3.1 Examens biologiques

4.1.3.2 Endoscopie digestive

4.1.3.2.1 Examens de 1re intension

4.1.3.2.2 Examens de 2me intension

4.1.3.2.3 Exploration du grele:

4.1.3.2.4 Angio-scanner

4.1.3.2.5 Scanner abdominal

4.1.3.2.6 Atériographie coelio-mésentérique

4.1.3.2.7 Scintigraphie aux globule rouge marques au Technicium 99

4.2 Etiologies

4.2.1 Etiologies Proctologiques

4.2.1.1 Hémorroïdes

4.2.1.2 Fissure anale

4.2.1.3 Cancer anal

4.2.1.4 Autres étiologies

4.2.2 Etiologies colo-rectales

4.2.2.1 Hémorragie diverticulaire

4.2.2.2 Angiodysplasie colique

4.2.2.3 Les colites

4.2.2.3.1 Les colites inflammatoires

4.2.2.3.2 Les colites infectieuses

4.2.2.3.3 Les colites ischémiques

4.2.2.4 Causes Tumorales

4.2.2.4.1 Les polypes volumineux (tumeurs vilieuses)

4.2.2.4.2 Les Cancers coliques

4.2.2.5 Causes Iatrogènes

4.2.3 Causes intestinales

4.2.3.1 Angiodysplasies du grêle

4.2.3.2 Ulcérations du grêle

4.2.3.3 Tumeurs du grêle

4.2.3.4 Diverticule de Meckel

5 Prise en charge spécifique

5.1 Hémorroïdes

5.2 Fissure anale

5.3 Ulcération thermométrique

5.4 Hémorragie diverticulaire

5.5 Colites inflammatoires

5.6 Angiodysplasie colique :

5.7 Polypes et tumeurs colorectales

5.8 Diverticule de Meckel

Conclusion

Introduction

L'hémorragie digestive est l'une des principales **urgences** en hépatogastroentérologie, elle impose presque toujours une **hospitalisation**.

Une hémorragie digestive **basse** est un **saignement** émis par **l'anus** traduisant une lésion située **en aval** de l'angle de **Treitz**. Le diagnostic est souvent évident et le pronostic est favorable conditionné par la rapidité de la prise en charge

1 Définitions

1.1 Le méléna

- L'émission de **selles** très **noires** (on a coutume de dire « noir comme du goudron »)
- Particulièrement **nauséabondes** (odeur caractéristique) correspondant à du sang digéré.
- Il traduit une hémorragie digestive **haute** ou **basse** (grêlique ou colique droite en général ; au-delà, le saignement digestif prend le plus souvent la forme de rectorragies).

1.2 L'hématochésie

- Correspondent à l'émission de sang **rouge** par **l'anus**.
- Traduisent une hémorragie digestive **basse** dans la majorité des cas, mais peuvent être en rapport avec une hémorragie digestive **haute massive**.

1.3 Rectorragie

- Un terme qui doit être restreint aux saignements d'origine **rectale**.

1.4 Saignement d'origine anale

- Emission de sang **rouge** souvent au décours d'un épisode **défécatore**.
- Non mélangé aux matières.
- Ou du sang tachant le papier hygiénique.

1.5 Hémorragie occulte

- Révélée par la recherche du sang dans les selles (hemocult*) positive.
- Se traduit généralement par une anémie microcytaire par carence martiale.

2 Epidémiologie

- Une des principales urgences en hépatogastroentérologie.
- Les hémorragies digestives sont un peu plus fréquentes chez **l'homme** (sex-ratio = 3/2)
- Les hémorragies digestives basses sont moins **fréquentes** que les hémorragies digestives **hautes (20 % vs 80 %)**
- **L'âge** médian des patients est d'environ **70 ans**.
- La **mortalité** globale des hémorragies digestives va de **2 à 08%** selon les études.
- L'incidence et la mortalité des hémorragies digestives est en légère diminution (progrès diagnostiques et thérapeutiques), elle est fortement liée aux tarres associées.
- **1/3** des **décès** sont directement liés au saignement (hémorragie **massive**)
- **2/3** des décès sont en rapport avec la **décompensation** des **tares** sous-jacentes.

3 Conduite à tenir initiale

- Comprend les étapes suivantes :
 1. Affirmer le **diagnostic** d'hémorragie digestive.
 2. Eliminer les diagnostics **différentiels**.
 3. Apprécier la **gravité** de l'hémorragie (retentissement).
 4. Entamer les mesures **thérapeutiques d'urgence**.

3.1 Affirmer le diagnostic d'hémorragie digestive

- Le diagnostic d'hémorragie digestive est le plus souvent **évident**.
- Repose sur l'interrogatoire et l'examen clinique si l'hémorragie persiste lorsque le malade consulte.
- Le **toucher rectal** est systématique à la recherche de sang rouge et/ou de méléna.

3.2 Eliminer les diagnostics différentiels

- Eliminer tout ce qui n'est **pas** une **hémorragie** :
 - Aliments (**betterave, reglisse**) ou boissons (**vin**) colorés.
 - Supplément en Fer, Charbon ou sels de bismuth.
- Eliminer tout ce qui n'est **pas** une **hémorragie digestive**:
 - Saignement uro-génital
 - Saignement cutané
- Eliminer tout ce qui n'est **pas** une **hémorragie digestive basse**:
 - Hémorragie digestive haute de grande abondance.

3.3 Apprécier la gravité de l'hémorragie (retentissement)

3.3.1 Démarche

3.3.1.1 Interrogatoire

- L'interrogatoire est peu utile pour estimer la quantité de sang extériorisée car très souvent exagérée par les patients ou leurs proches mais permet une approximation grossière :
 - Quantité < 500 cc → hémorragie minime.
 - Quantité entre 500 et 1000 cc → hémorragie de moyenne abondance.
 - Quantité > 1000 cc → hémorragie de grande abondance.
- Par ailleurs, il permet de rechercher :
 - La notion de **malaise** (signe de gravité),
 - **Angine de poitrine** (signe rare mais gravissime d'une mauvaise tolérance au saignement)
 - La présence de **tares** associées (pouvant être décompensés par le saignement).

3.3.1.2 Examen clinique

- La présence de **signes de choc** est un élément de **gravité**.
 - Troubles de la conscience/vigilance (syncope, lipothymie), et troubles neuropsychiques
 - Tachycardie, FC > 120 bt/mn, signe le plus précoce.
 - Hypotension PAS < 10 cm Hg, plus tardive; elle est initialement orthostatique puis permanente.
 - Signes périphériques : sueur pâleur, marbrures, augmentation du temps de recoloration cutanée, froideur des extrémités.
 - Polypnée
 - Oligo-anurie.
- Une hémorragie cliniquement **active** est une hémorragie **grave**
- L'examen clinique doit être compléter par :
 - **Un toucher rectal** systématique devant toute HD basse +/- examen proctologique complet
 - Le reste de l'examen clinique dépendra des **signes d'appel**.

3.3.1.3 Examens para-cliniques

3.3.1.3.1 Les examens biologiques

- Permettent une évaluation rapide et accessible du retentissement du saignement, par contre leur normalité n'élimine pas un saignement grave.
 - FNS hémoglobine et hématocrite : **Hte < 28 %** → signe de **gravité**.
- Autres tests sont indispensables :
 - Bilan d'hémostase (TP, TCA, TQ)
 - Bilan pré-transfusionnel (Groupage, Rh)
 - Autres (ionogramme, bilan hépatique, urée/créat)

3.3.1.3.2 ECG

- Est à faire systématiquement.

3.3.1.3.3 Examen endoscopique

- L'anuscopie, la rectoscopie ou la colonoscopie
- Objective et localise le saignement
- Précise le caractère **actif** ou non du saignement.

3.3.1.4 Evaluer l'évolution

- Préciser le volume de **culots globulaires** transfusés pendant 24 h pour maintenir un état hémodynamique stable (< / > 06 culots)

3.3.2 Critères de gravité

3.3.2.1 Critères de KAMMOK

- Perte sanguine > **1000 cc/24 h** ou de **30 %** de la masse sanguine
- Présence de signes de **choc**
- **Hte < 28 %** , **GR < 2,5 M/mm³**, **Hb < 8 g/dl**
- Hémorragie nécessitant une transfusion de plus de **1500 cc / 24** pour maintenir un état hémodynamique stable

3.3.2.2 Autres critères :

- Saignement **en jet** visualisé par l'endoscopie digestive
- Terrain particuliers :
 - Agé > 60 ans
 - Tarres associées : insuffisance coronaire, respiratoire ou rénale.

3.4 Mesures thérapeutiques d'urgence

- Hospitalisation tout patient présentant une hémorragie digestive, sauf si le saignement est minime sans retentissement hémodynamique.
- Mise en place de 2 voies d'abords périphériques ou une voie centrale
- Prélèvement sanguin pour : FNS, groupage, bilan d'hémostase.
- Monitoring (TA, Fc, SpO₂)
- Oxygénothérapie si besoin
- Sonde naso-gastrique
- Remplissage vasculaire par macromolécule et +/- transfusion pour obtenir :
 - FC : **100 bt/mn**.
 - PAS: > **10 cm Hg**.
 - HB: > **8 g/dl**.
 - Diurèse : > **30 ml/h**.
 - Surveillance des paramètres vitaux: FC, PA, SO₂, Diurèse.

4 Diagnostic Etiologique

4.1 Enquete Etiologique

4.1.1 Anamnèse

- L'interrogatoire du patient ou de son entourage à la rechercher de :

4.1.1.1 Terrain

- Age.
- Tarres associées: Diabète, HTA, IR.

4.1.1.2 ATCD personnels

- Vasculaires, coagulopathie.
- Cardiopathie.
- Maladie inflammatoire chronique de l'intestin.
- Diverticulose.
- Néoplasie ou polype digestive.
- Resection récente d'un polype.
- Chirurgie sur le tube digestif.
- Maladie hémorroïdaire.

4.1.1.3 Antécédents familiaux

- Polypose
- Cancer colorectal

4.1.1.4 Nature du saignement

- Rectorragie,
- Miléna
- Assoiation

4.1.1.5 Caractères du saignement

- Abondance.
- Fréquence.
- Ancienneté.
- Notion de caillots.

4.1.1.6 Circonstances de survenue:

- Prise de température par voie rectale.
- Traitement anticoagulant ou anti-inflammatoire.
- Notion de traumatisme ano-rectal ou autre.

4.1.1.7 Rapport des rectorragies avec la défécation

- Isolées en dehors des selles ;
- Précédent, accompagnant ou suivant les selles.

4.1.1.8 Prise médicamenteuse:

- AINS.
- Anticoagulant.

4.1.1.9 Signes accompagnateurs

4.1.1.9.1 Signes généraux

- Fièvre.
- Altération de l'état general
- Amaigrissement

- Anorexie
- Syndrome inflammatoire

4.1.1.9.2 Signes digestifs

- Douleur abdominale.
- Diarrhées sanglante.
- Syndrome rectal

4.1.2 Examen physique

- Doit être complet

4.1.2.1 Examen proctologique

- Toucher rectal à la recherche d'une masse perceptible
- Examen de la marge anale
- Anuscopie.

4.1.2.2 Examen de l'abdomen

- Recherchera : une douleur provoquée,
- Ou une masse abdominale.

4.1.2.3 Examen général

- Télangiectasies,
- Adénopathies.

4.1.3 Examens complémentaires

4.1.3.1 Examens biologiques

- Groupage-Rh
- F.N.S
- Bilan d'hémostase
- V.S
- Ionogramme sg
- Urée sg
- Glycémie.

4.1.3.2 Endoscopie digestive

4.1.3.2.1 Examens de 1re intention

1. Anuscopie et Recto-sigmoïdoscopie

- Permet de détecter certaines causes de saignement :
 - Lésion hémorroïdaire
 - Fissure anale
 - Cancer de l'anus
 - Ulcère du rectum
- Doit être complété par une colonoscopie à la recherche d'une lésion hémorragique du colon du colon d'amont

2. Colonoscopie totale

- Pratiquée chez un patient réanime en première intention stable hémodynamiquement
- Nécessite une préparation par voie orale (PEG) par fois par une sonde naso-gastrique
- Permet :

- La mise en évidence du site du saignement.
- Apprécier son caractère actif ou des stigmates de saignement récent.
- Un diagnostic étiologique
- Faire des biopsies.
- Traiter une éventuelle hémorragie active.

4.1.3.2.2 Examens de 2^{me} intention

- En cas de négativité des examens endoscopiques initiaux

4.1.3.2.3 Exploration du grele:

- Enteroscopie
- Video-capsule
- Enteroscan

4.1.3.2.4 Angio-scanner

- Permet de rechercher des signes directes ou indirectes d'angiodysplasie colique
- Visualisation localisée inhabituelle au sein de la paroi colique.
- Un retour veineux précoce.
- Une augmentation du calibre d'une artère de suppléance.

4.1.3.2.5 Scanner abdominal

- Réalisée dans les 24 premières heures est une méthode non invasive
- Permettant d'aider au diagnostic étiologique d'une HDB à la phase aiguë, surtout en cas d'échec ou d'impossibilité de la coloscopie

4.1.3.2.6 Artériographie coelio-mésentérique

- Examen invasif
- Réalisée en cas de saignement persistant de cause imprécise ou état hémodynamique instable malgré les mesures de réanimation.
- Elle nécessite un débit sanguin de 0,5 à 01 ml/mn pour visualiser le saignement
- Elle permet un geste thérapeutique /embolisation, injection de produit vasoactif.

4.1.3.2.7 Scintigraphie aux globule rouge marqués au Technicium 99

- Intérêt limité dans ces situations d'urgence (si état hémodynamique instable)
- Met en évidence un saignement digestif de l'ordre de 0,1 ml/mn.
- En cas de positivité, elle permet de sélectionner des malades ayant une hémorragie active pour lesquels une artériographie serait utile.

4.2 Etiologies

4.2.1 Etiologies Proctologiques

4.2.1.1 Hémorroïdes

- Cause la plus fréquente.
- Rectorragies minimales qui suivent la selle.
- Sang rouge vif (sans caillot).
- Eclaboussant la cuvette ou tachant le papier hygiénique.
- Cédant en quelques minutes.
- En général indolore ou s'accompagne d'une gêne anale.

4.2.1.2 Fissure anale

- Rectorragies minimales, tachant le papier

- Associé au syndrome fissuraire ou douleur en trois temps: (Douleur au passage de la selle-disparition de la douleur-réapparition de la douleur.)
- Associé à une constipation ou une hypertrophie du sphincter anal.

4.2.1.3 *Cancer anal*

- Peu fréquent
- Douleurs et trouble du transit
- Dgc : Examen proctologique +biopsie

4.2.1.4 *Autres étiologies*

- **Corps étranger anal.**
- **Agression.**
- **Lésions anorectales sexuellement transmissibles.**
- **Infections bactériennes ou parasitaires.**

4.2.2 *Etiologies colo-rectales*

4.2.2.1 *Hémorragie diverticulaire*

1. **Definition**

- Elles représentent environ **40 % des hémorragies digestives basses.**
- Elles sont en rapport avec la **rupture d'une artériole** au contact d'un diverticule colique.

2. **Clinique**

- Rectorragies indolores, rarement massives.
- Arrêt spontané dans 80 % des cas.
- Récidive possible à court et moyen terme.

3. **Coloscopie**

- Il faut idéalement visualiser l'hémorragie au niveau d'un orifice diverticulaire (rare).
- En cas de saignement actif, l'hémostase endoscopique passe par l'injection de sérum adrénaliné et/ou la mise en place de clip(s)
- Par contre, la seule présence de diverticules coliques est banale et ne permet pas de leur imputer de façon certaine le saignement même si c'est un argument indirect.

4.2.2.2 *Angiodysplasie colique*

1. **Definition**

- Elles sont à l'origine d'environ 15 % des hémorragies digestives basses.
- Ce sont des anomalies vasculaires dégénératives correspondant à des dilatations anormales de veines sous-muqueuses (synonyme = ectasie vasculaire).
- Elles se rencontrent surtout chez le sujet âgé et sont statistiquement associées à un rétrécissement aortique ou une insuffisance rénale chronique.
- Il existe dans 20 % des cas environ des angiodysplasies de la grêle associées.

2. **Clinique**

- Anémie par carence martiale le plus souvent, sans hémorragie extériorisée.
- Parfois rectorragies et/ou méléna.

3. **Colonoscopie**

- Lésions planes ou légèrement saillantes, rouges, rondes, stellaires ou en arceau, mesurant quelques millimètres de diamètre.

- Elles sont plus souvent localisées au niveau du côlon droit et du cœcum.
- L'hémostase endoscopique est nécessaire en cas de saignement actif voire en cas de saignement récent supposé (méthode thermique++).

4.2.2.3 Les colites

4.2.2.3.1 Les colites inflammatoires

4.2.2.3.1.1 Maladie de Crohn

1. Clinique

- Douleurs abdominales, **diarrhées** (parfois sanglantes), perte de poids, **fièvre**, et complications comme les **fistules et les sténoses**.

2. Aspect endoscopique

- Lésions **discontinues** avec des zones saines intercalées entre les segments affectés.

3. Localisation

- Peut affecter n'importe quelle partie du tube digestif, **de la bouche à l'anus**, avec une prédilection pour l'iléon terminal et le côlon droit.

4.2.2.3.1.2 Rectocolite hémorragique

1. Clinique

- **Diarrhées** sanglantes, douleurs abdominales, ténesme, et risque accru de cancer colorectal.

2. Aspect endoscopique

- Lésions continues sans zones saines intercalées.

3. Localisation

- Limitée au colon et au rectum, touchant principalement le colon gauche et le rectum.

4.2.2.3.2 Les colites infectieuses

- **Yersinia**
- **Entamoeba**
- **Campylobacter**
- **CMV**

4.2.2.3.3 Les colites ischémiques

4.2.2.4 Causes Tumorales

4.2.2.4.1 Les polypes volumineux (tumeurs villeuses)

- sont rarement responsables d'hémorragies digestives aiguës mais peuvent être à l'origine de rectorragies chroniques intermittentes.
- La coloscopie évoque le diagnostic et les biopsies le confirment.

4.2.2.4.2 Les Cancers coliques

- Le plus souvent responsables de saignement minime.
- Mais peut présenter dans certains cas 10 à 20 % des étiologies
- **Adénocarcinomes**
- **Lymphomes**

4.2.2.5 Causes Iatrogènes

- Cause médicamenteuses (AINS)

- **Ulcération thermométrique**
- **Rectites radiques**

4.2.3 Causes intestinales

4.2.3.1 Angiodysplasies du grêle

- 1^{re} cause d'hémorragie digestive d'origine intestinale.
- Il s'agit des mêmes que celles décrites au niveau du côlon. Même terrain et elles peuvent être associées à des angiodysplasies coliques.
- **Clinique:**
 - **Anémie** par carence martiale le plus souvent, sans hémorragie extériorisée.
 - Parfois rectorragies ++, voire méléna

4.2.3.2 Ulcérations du grêle

- Des ulcérations du grêle peuvent être en rapport avec une maladie de Crohn intestinale. Cependant, elles se manifestent rarement par une hémorragie digestive et sont rarement révélatrices de la maladie.
- Sinon, elles peuvent être d'origine **médicamenteuse**, en particulier dues aux AINS.

4.2.3.3 Tumeurs du grêle

- Les tumeurs de l'intestin grêle sont **rares**, beaucoup plus rares que le cancer colorectal
- Révélées par une hémorragie digestive dans environ 1/4 des cas.
- Les formes histologiques les plus fréquemment rencontrées sont :
- **Les adénocarcinomes** (risque si maladie de Crohn du grêle ou de maladie cœliaque ++).
- **Les lymphomes.**
- **Les tumeurs endocrines.**
- **Les tumeurs stromales (GIST).**

4.2.3.4 Diverticule de Meckel

- Anomalie congénitale correspondant à une persistance partielle du canal omphalo-mésentérique.
- Il est présent chez 2 à 4 % des individus, il s'agit d'un diverticule iléal localisé sur le bord anti-mésentérique, à la terminaison de l'artère mésentérique supérieure
- Peut-être tapissé d'une **muqueuse intestinale**, il est alors **asymptomatique** ou d'une **muqueuse** dite **hétérotopique**, notamment **gastrique**, à l'origine possible de **complications**.
- 3 complications à connaître+++ :
 - **Inflammation** = diverticulite et ses complications propres = tableau pseudo-appendiculaire, voire abcès ou péritonite par perforation.
 - **Invagination** intestinale aiguë = occlusion intestinale aiguë du grêle par strangulation
 - **Ulcération** « peptique » de la muqueuse iléale avoisinante = hémorragie digestive basse extériorisée - rectorragies et/ou méléna - ou non = anémie par carence martiale.
- **Diagnostic :**
 - **Scintigraphie au Technétium^{99m}** qui objective un foyer anormal de fixation au niveau du grêle en cas d'hétérotopie gastrique.

- Eventuellement par artériographie sélective en cas d'hémorragie abondante.

5 Prise en charge spécifique

5.1 Hémorroïdes

- Traitement médical compléter par un traitement chirurgical ambulatoire si indication

5.2 Fissure anale

- Traitement chirurgical.

5.3 Ulcération thermométrique

- Coagulation ou tamponnement au spongel imbibé de thrombase.

5.4 Hémorragie diverticulaire

- En cas de saignement actif, l'hémostase endoscopique passe par l'injection de sérum adrénaliné et/ou la mise en place de clip(s)
- Par contre, la seule présence de diverticules coliques est banale et ne permet pas de leur imputer de façon certaine le saignement même si c'est un argument indirect.
- En cas d'échec ou d'impossibilité d'hémostase endoscopique et de saignement persistant et menaçant, un **angioscanner pourra** localiser le niveau de l'hémorragie et permettra de guider une **embolisation artérielle** par voie radiologique.
- A défaut, ou en cas d'échec de l'embolisation, faire appel à la chirurgie

1. Diverticectomie simple

- Indiquée si le diverticule est isolé et sans inflammation importante des structures voisines.
- Consiste en l'exérèse du diverticule à sa base, avec fermeture directe de l'intestin.

2. Colectomie segmentaire

- Si un examen morphologique a permis de localiser le saignement.

3. Colectomie subtotale

- Avec iléostomie et sigmoïdostomie dans les autres situations

5.5 Colites inflammatoires

- **RCH** : Colectomie totale en cas d'échec du traitement médical.
- **Maladie de Crohn** : Traitement chirurgical

5.6 Angiodysplasie colique :

- Traitement endoscopique (coagulation, laser)
- Traitement chirurgical (résection colique) si le pronostic vital est mis en jeu

5.7 Polypes et tumeurs colorectales

- En cas de cancer → traitement chirurgicale
- En cas de polype > 1cm → exérèse endoscopique.

5.8 Diverticule de Meckel

- Résection chirurgicale segmentaire de l'intestin grêle
- Indiquée en cas de :
 - *Suspicion ou présence confirmée de tissu ectopique gastrique ou pancréatique.
 - *Inflammation importante impliquant la base du diverticule et l'intestin adjacent.
 - *Perforation ou nécrose intestinale.
- Inclut l'ablation du segment de l'intestin grêle contenant le diverticule et une anastomose termino-terminale.

Conclusion

Les hémorragies digestives présentent une véritable urgence médicochirurgicale pouvant mettre en jeu le pronostic vital, elle nécessite une étroite collaboration entre médecins réanimateurs, endoscopistes et chirurgiens. Les hémorragies digestives basses sont moins fréquentes que les hémorragies digestives hautes et qui sont souvent d'origine colique. En cas d'HDB persistante, il faut réaliser une colonoscopie après une préparation colique, qui permet de poser le diagnostic et faire dans certains cas un geste thérapeutique.